

BIH-CEI · Berlin Institute of Health at Charité

LG-05 Überleitung in das MII-Modul

Spezifikation „Onkologische Therapieziele“

Liefergegenstand: LG-05 · MII-Integrationskonzept

Auftrag: Gematik C002717

Adressat: KIG / Auftraggeber

Einreichung: Kommentierungskommentar, laufende Kommentierung

Zieltermin: Integration bis Ende 2027

Stand: 30.09.2026

Projektleitung: Prof. Dr. Sylvia Thun

Technische Leitung FHIR: Thomas Debertshäuser

Inhaltsverzeichnis

Überleitung der Datenpunkte in das MII-Kerndatensatzmodul Onkologie

Liefergegenstand LG-05 · Spezifikation „Onkologische Therapieziele“ · Gematik-Auftrag C002717 · BIH-CEI

Bezugsfassung des Leitfadens: aktueller Stand nach Umsetzung der Ballot-Kommentare und dem Episodenart-Umbau, aufsetzend auf der kommentierten Fassung 1.0.0-ballot.

Zusammenfassung

Der Implementierungsleitfaden „Therapieziele Onkologie“ (de.bih-cei.therapieziele-onkologie) wird derzeit auf GitHub entwickelt und gehostet: Quellen unter github.com/BIH-CEI/TherapiezieleOnkologie, gerendert unter bih-cei.github.io/TherapiezieleOnkologie. Er ist so konstruiert, dass er **kein paralleles Datenmodell** aufbaut, sondern das MII-Kerndatensatzmodul Onkologie als Datenelemente- und Terminologiebasis nutzt (Architekturentscheidung ADR-0013). Dieses Dokument weist nach, dass **jeder** im Leitfaden eingeführte Datenpunkt einen definierten Landeplatz hat, und benennt für jeden Datenpunkt Ziel, Überleitungsweg, Abhängigkeit und Entscheidungsbedarf.

Kernaussagen

1. **Der Leitfaden schließt eine substanzielle Lücke.** Das MII-Modul Onkologie kennt weder ein Goal- noch ein EpisodeOfCare-Profil. Behandlungsziel, Zielakzeptanz (Shared Decision), Zielerreichung und der Behandlungsabschnitt als eigene Entität sind im Kerndatensatz derzeit nicht abbildbar. Das ist keine Randlücke: Sie betrifft genau die Datenpunkte, die die gematik beauftragt hat.
2. **Die Überleitung folgt fünf Wegen** — neue Profile im MII-Modul Onkologie (Therapieziel, Behandlungsepisode), Aufgehen in bestehenden MII-Profilen (Empfehlungsplan und Tumorboard-Empfehlungen in MII_PR_Onko_Tumorkonferenz und die Therapieempfehlungs-Profile), bereits gedeckte Artefakte, die bei der Überleitung ersatzlos entfallen (Tumordiagnose), Einreichung bei ISiK — perspektivisch Überführung in die Kernprofile — mit onkologischer Ableitung im MII-Modul (Behandlungs- und Diagnostikplan) sowie Verbleib im Leitfaden (Szenarien, logisches Modell, entitätsübergreifende Kapitel).

3. **Die Einreichung erfolgt jetzt, die Integration bis Ende 2027.** Die Überleitung wird als **Kommentierungskommentar in die laufende Kommentierung** des Moduls eingebracht – das ist der reguläre Weg, auf dem eine Änderung in ein MII-Modul gelangt, und er steht offen, solange die Kommentierungsfrist läuft. Die inhaltliche Aufnahme der Profile und Terminologien erfolgt anschließend mit dem Release des Moduls; Zieltermin für die vollzogene Integration ist **Ende 2027**.
4. **Zwei Abstimmungen sind Voraussetzung, nicht Folge.** Erstens mit dem MII-Modul **Molekulares Tumorboard (MTB)**: Es leitet seinen MII_PR_MTB_Therapieplan bereits von mii-pr-onko-tumorkonferenz ab und führt seinerseits eine „Behandlungsepisode“ – allerdings als ClinicalImpression mit anderer fachlicher Bedeutung. Zweitens mit **ISiK**, das den Behandlungsplan als versorgungsnahes Artefakt aufnimmt – mit der Perspektive, ihn später auf die Ebene der **Kernprofile** zu heben, sobald er sich im Krankenhausbetrieb bewährt hat.
5. **Bei der Intention sind beide Seiten deckungsgleich, bei der Modalität nicht.** Der Leitfaden trennt inzwischen wie das MII-Modul: Intention beantwortet das *Wozu* (kurativ, palliativ, supportiv), die Stellung zur Operation (neoadjuvant, adjuvant, intraoperativ, additiv) steht in einer eigenen Kontext-Achse und deckt damit mii-cs-onko-therapie-stellungzurop ab. Offen bleibt mii-cs-onko-therapie-typ, das Behandlungsmodalität (Chemo-, Hormon-, Immuntherapie) und Versorgungsstrategie (Watchful Waiting, Active Surveillance) in einer Liste vermischt, die der Leitfaden in zwei Merkmale trennt – Episodenart und Modalität. Das ist über ConceptMaps auflösbar, muss aber entschieden werden.

Mengengerüst der Überleitung

Weg	Artefakte	Ziel
A – Neues Artefakt im MII-Modul Onkologie	2 Profile, 8 Extensions, 5 CodeSystems, 11 ValueSets, 4 ConceptMaps	MII KDS Onkologie
B – Aufgehen in bestehendem MII-Profil	4 bestehende Profile werden ergänzt	MII KDS Onkologie
C – Bereits gedeckt	Tumordiagnose und Ergebnis-Observations; im Leitfaden bereits vollzogen	–
D – Einreichung bei ISiK, später Kernprofile, Ableitung im MII-Modul	1 Profil (zwei Ausprägungen)	ISiK → Kernprofile → MII
E – Verbleibt im Leitfaden	logisches Modell, Beispiele, 4 Entitätskapitel	BIH-CEI

1 Auftrag, Gegenstand und Abgrenzung

1.1 Auftrag

Die Spezifikation „Onkologische Therapieziele“ wurde am 02.04.2026 von der gematik (Vertrag C002717) beauftragt und soll als FHIR-Implementation-Guide vorliegen, **ergänzt um ein Konzept zur MII-Integration**. Dieses Dokument ist dieses Konzept in seiner ausführenden Form: Es beschreibt nicht, *ob* integriert wird, sondern *wie* jeder einzelne Datenpunkt in das MII-Modul übergeht.

1.2 Gegenstand

Gegenstand sind sämtliche im Leitfaden definierten Artefakte im aktuellen Stand:

- **5 Profile** — OnkoTherapyGoal (Goal), OnkoCarePlan (CarePlan), OnkoBehandlungsepisode (EpisodeOfCare), TumorboardServiceRequest, TumorboardMedicationRequest
- **9 Extensions**, davon 8 projekteigene
- **5 CodeSystems, 11 ValueSets, 1 ConceptMap**
- **1 logisches Modell** (TherapiezielDreieck) mit 51 Datenelementen
- **6 Invarianten**

Gegenüber der kommentierten Ballot-Fassung entfallen zwei Profile ersatzlos: DiagnosticCarePlan und OnkoCondition. Der diagnostische Abschnitt wird seither über CarePlan.category (ValueSet onko-care-plan-phase) vom therapeutischen unterschieden statt über ein zweites Profil; die Tumordiagnose wird direkt über das MII-Diagnoseprofil referenziert, ohne eigene Ableitung. Beides geht auf die Kommentierung zurück und ist für die Überleitung eine Erleichterung — zwei Artefakte weniger, die überzuleiten wären.

Die Datenpunkt-Ebene dieses Dokuments ist das **logische Modell**, nicht die FHIR-Elementliste. Das logische Modell ist die fachliche Normalform des Leitfadens; die FHIR-Pfade sind seine Realisierung. Die Überleitung muss auf der fachlichen Ebene tragen, sonst überträgt sie Implementierungszufälle.

1.3 Abgrenzung

Zielmodul dieser Überleitung ist ausschließlich das **MII-Kerndatensatzmodul Onkologie**. Ob überhaupt Landeplätze in Nachbarmodulen (Medikation, Prozedur, Fall, PROs, Studie) benötigt werden, ist noch zu prüfen; wo sie die Überleitung berühren, werden sie benannt, aber nicht ausmodelliert. Für die Terminologie-Anbindung an das MII-Modul MTB gilt dasselbe: Abstimmungsbedarf wird benannt, die Abstimmung selbst ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.

Nicht Gegenstand sind ferner die ePA-Dokumentenarchitektur (ADR-0001 ff.), die CPG-on-FHIR-Anbindung (ADR-0011) und die EHDS-Brücke nach IPS/EPS (ADR-0014). Diese Schichten liegen oberhalb bzw. seitlich des Kerndatensatzes, da sie sich mit den strukturellen

Datenaustauschformaten bzw. der abstrakten Abbildung von Leitlinien befassen und nicht mit den konkreten instanziierten Datenelementen selbst.

2 Ausgangslage

2.1 Der Leitfaden

Der Leitfaden modelliert das **Therapieziel-Dreieck**: Behandlungsepisode (*wer behandelt in welchem Abschnitt*), Therapieziel (*was soll erreicht werden*) und Versorgungsplan (*was ist geplant*). Das tragende Prinzip ist, dass **das Ziel dem Plan vorausgeht**: Erst wird — per Shared Decision bzw. Tumorboard — das Ziel festgelegt, dann folgt der Plan zu seiner Erfüllung. CarePlan.goal ist eine Verfolgungs-Referenz, kein Besitz.

Der Leitfaden ist bereits heute an MII gekoppelt: Die Abhängigkeit auf de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.onkologie ist in sushi-config.yaml gepinnt, und sämtliche Diagnosereferenzen zeigen über targetProfile direkt auf mii-pr-onko-diagnose-primaertumor. Die Überleitung ist damit kein Bruch, sondern die Fortsetzung einer bestehenden Kopplung.

Zur Fassungslage. Die Kommentierung lief auf 1.0.0-ballot — zuletzt vor Beginn der Kommentarumsetzungen am 03.08.2026 veröffentlicht. Seither ist der Leitfaden in zwei Schritten fortentwickelt worden: zunächst durch die **Umsetzung der eingegangenen Kommentare** — dabei entfielen die Profile DiagnosticCarePlan und OnkoCondition, und es kamen die Kontext-Extension sowie die ValueSets für CarePlan-Phase und Zielbeginn hinzu —, anschließend durch den hier beschriebenen **Episodenart-Umbau**. Dieses Dokument beschreibt den Stand nach beiden Schritten. Wo er von der kommentierten Fassung abweicht, ist das ausgewiesen; der Kommentar selbst muss diese Fortentwicklung offenlegen (Risiko 6).

2.2 Das MII-Modul Onkologie

Das Modul ist oBDS-getragen: Sein logisches Modell (MII_LM_Onko) bildet Diagnose, Histologie, TNM, Residualstatus, Fernmetastasen, Leistungszustand, Operation, Strahlentherapie, systemische Therapie, Nebenwirkungen, Verlauf, Tumorkonferenz, Tod, genetische Variante und Studienteilnahme ab. Es ist damit stark auf **Befund und durchgeführte Maßnahme** ausgerichtet.

Was es **nicht** enthält (geprüft gegen 2027.0.0-ballot.1, 98 StructureDefinitions):

Fehlendes Konzept	Konsequenz
Kein Goal-Profil	Behandlungsziel, Zielwert, Zielerreichung und Zielakzeptanz sind nicht abbildbar
Kein EpisodeOfCare-Profil	Der Behandlungsabschnitt existiert nur implizit über Zeiträume an Prozeduren
Keine Therapielinien-Zählung	Line of Therapy (LoT) ist weder

Fehlendes Konzept	Konsequenz
Kein Shared-Decision-Element	dokumentierbar noch auswertbar Nur Therapieabweichung auf Patientenwunsch (J/N/U) am Empfehlungspunkt
Keine Ziel-Ergebnis-Verknüpfung	Verlauf und Residualstatus existieren, sind aber an kein Ziel gebunden

Vorhanden und für die Überleitung tragend sind: MII_PR_Onko_Tumorkonferenz (CarePlan), MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Medikation (MedicationRequest), MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Operation (ServiceRequest), MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Kombinationstherapie (RequestGroup), MII_PR_Onko_Systemische_Therapie (Procedure), MII_PR_Onko_Verlauf und MII_PR_Onko_Residualstatus (Observation).

2.3 Das MII-Modul MTB als Nachbar

Das Modul Molekulares Tumorboard ist für diese Überleitung kein entferntes Nachbarmodul, sondern ein direkter Vorbelegungsfall:

- MII_PR_MTB_Therapieplan (CarePlan) **leitet bereits von mii-pr-onko-tumorkonferenz ab**. Das ist das Muster, dem die Überleitung des Empfehlungsplans folgen muss – und zugleich die Randbedingung: Jede Ergänzung an Tumorkonferenz wirkt sich auf MTB aus.
- MII_PR_MTB_Behandlungsepisode trägt denselben Begriff wie unser Profil, ist aber eine **ClinicalImpression** – fachlich eine Fallvorstellung mit Zustandsbild und Voruntersuchungen, nicht ein Versorgungsabschnitt mit Intention und Zeitraum. Begriffskollision bei unterschiedlicher Semantik.
- MII_EX_MTB_Empfehlung_Prioritaet und MII_EX_MTB_Empfehlung_Evidenzgraduierung sind funktional benachbart zu unserer Zielpriorität bzw. Leitlinienbindung. Dabei ist die Ausgangslage im MTB eine besondere: Patientinnen und Patienten, die eine vertiefende Diagnostik an einem Molekularen Tumorboard erhalten, sind häufig entweder bereits „austherapiert“ – die Leitlinien sehen keine weiteren Therapien vor –, oder es handelt sich um seltene Tumore, für die es keine oder wenig übergreifende Evidenz gibt und die daher direkt personalisiert behandelt werden. Eine Leitlinienbindung des Zielwerts trägt in diesen Fällen nicht; das Ziel muss individuell begründbar bleiben.

2.4 Versionsbezug

Artefakt	Version	Anmerkung
Leitfaden	1.0.0-ballot	de.bih-cei.therapieziele-onkologie
Abhängigkeit im Leitfaden gepinnt	2026.0.3	Stand sushi-config.yaml
Analysegrundlage dieses Dokuments	2027.0.0-ballot.1	aktuell ballotierendes Modul
Zielversion der Überleitung	Fassung, die aus der laufenden Kommentierung hervorgeht	Einreichung als Kommentierungskommentar; Integration bis Ende 2027

Folgeaufgabe: Das Pinning im Leitfaden ist auf die Release-Version nachzuziehen, sobald das Modul veröffentlicht ist (AP 8). Bis dahin beziehen sich alle Aussagen dieses Dokuments auf

2027.0.0-ballot.1; Abweichungen zum jeweils aktuellen Kommentierungsstand sind vor der endgültigen Disposition erneut zu prüfen.

3 Überleitungsstrategie

3.1 Fünf Wege

Weg	Bedeutung	Kriterium
A	Neues Artefakt im MII-Modul Onkologie	Kein Pendant vorhanden; das Artefakt geht ins MII-Modul Onkologie über und wird dort weiterentwickelt und gepflegt
B	Aufgehen in bestehendem MII-Profil	Pendant vorhanden, Erweiterung reicht aus; kein zweites Profil für dieselbe Sache
C	Bereits gedeckt	Der Leitfaden leitet ab bzw. referenziert; bei Überleitung entfällt das eigene Artefakt
D	Einreichung bei ISiK, später Kernprofile, Ableitung im MII-Modul	Versorgungsnahes, nicht onkologiespezifisches Artefakt mit onkologischer Ausprägung
E	Verbleibt im Leitfaden	Erläuternd, beispielhaft oder entitätsübergreifend; gehört nicht in einen Kerndatensatz

Leitprinzip bei der Zuordnung: **kein zweites Profil für dieselbe Sache**. Wo das MII-Modul bereits eine Entität führt, wird sie ergänzt, nicht dupliziert. Das ist der Grund, warum der Empfehlungsplan in Tumorkonferenz aufgeht und nicht als eigenes Profil danebentritt.

3.2 Zeitpunkt und Einreichungsweg

Einreichung und Integration fallen zeitlich auseinander, und das ist beabsichtigt.

Einreichung: jetzt, als Kommentierungskommentar. Die Überleitung wird als Kommentar in die **laufende Kommentierung** des Moduls

de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.onkologie eingebracht. Das ist kein Umweg, sondern der reguläre Weg: Die Kommentierung ist genau das Verfahren, in dem inhaltliche Änderungen an einem MII-Modul vorgebracht und disponiert werden. Wer eine Erweiterung erst nach Abschluss der Kommentierung anmeldet, verliert einen vollen Modulzyklus.

Eingereicht wird **ein geschlossener Kommentar** mit diesem Dokument als Grundlage — nicht eine Zerlegung in Einzelvorschläge. Der Grund ist inhaltlich: Das Therapieziel-Dreieck trägt nur als Ganzes. Ein Therapieziel ohne Behandlungsepisode verliert das Episodenziel und die

Linienzuordnung; eine Episode ohne Ziel ist ein Zeitraum ohne Zweck; die Terminologien haben ohne die Profile keinen Anker. Eine stückweise Disposition — dieses Element ja, jenes vertagt — ergäbe einen Torso, der weder die beauftragten Datenpunkte abdeckt noch in sich konsistent wäre. Die Überleitung ist deshalb als **eine** Entscheidung vorzulegen und als eine zu disponieren.

Integration: mit dem Modul-Release, Zieltermin Ende 2027. Die tatsächliche Aufnahme der Profile, Extensions und Terminologien erfolgt in der Fassung, die aus der Kommentierung hervorgeht. Vollzogen — einschließlich der ConceptMaps, der MII-Ableitung des Behandlungsplans und des Rückbaus der Duplikate im Leitfaden — soll die Überleitung **bis Ende 2027** sein. Davon ausgenommen sind technische Änderungen, die sich aus der Integration der Ressourcen und aus der laufenden Kommentierung des Onkologie-Moduls ergeben, sowie die Korrektur redaktioneller und technischer Fehler.

Zwei Randbedingungen bleiben dabei bestehen:

- MII_PR_Onko_Tumorkonferenz wird durch Weg B verändert und ist Basis von MII_PR_MTB_Therapieplan. Die Kommentare zu Weg B betreffen damit zwei Module und sind entsprechend zu adressieren (siehe 3.3).
- Die Ballot-Fassung kann sich im Verlauf der Kommentierung noch ändern. Die Analyse dieses Dokuments bezieht sich auf 2027.0.0-ballot.1 und ist vor der endgültigen Disposition gegen den dann aktuellen Stand zu prüfen.

3.3 Abstimmungsbedarf vor Einreichung

Gegenüber	Gegenstand	Warum vorgelagert
MII AG Onkologie / TF KDS	Aufnahme von Therapieziel und Behandlungsepisode als neue Profile; Ergänzung von Tumorkonferenz	Modulhoheit
MII-Modul MTB	Begriff „Behandlungsepisode“; Auswirkung der Tumorkonferenz-Ergänzung auf MII_PR_MTB_Therapieplan ; Verhältnis Zielpriorität ↔ MII_EX_MTB_Empfehlung_Prioritaet	MTB erbt von Tumorkonferenz und belegt den Begriff bereits anders
ISiK	Aufnahme des Behandlungsplan-Profils	Besprochen und für die kommende Version 7.0 angedacht; Weg D setzt diese Aufnahme voraus, bevor das MII-Profil davon ableiten kann
HL7 Deutschland — Kernprofile	Perspektivische Überführung des Behandlungsplans auf die nationale Basisebene	Zielbild der Stufung; die Entscheidung fällt erst nach Bewährung in ISiK, die Kompatibilität ist aber

Gegenüber	Gegenstand	Warum vorgelagert
TC Terminologien / Interop Council	Trennung Episodenart ↔ Modalität gegenüber mii-cs-onko-therapie-typ	von Beginn an zu wahren Betrifft die oBDS-Kompatibilität des Kerndatensatzes. Die Intentionsfrage ist mit der Trennung von Intention und Kontext (6.2) entschieden und nur noch redaktionell nachzuziehen

4 Überleitung nach Artefakten

4.1 Therapieziel (Goal) → Weg A

Ziel: neues Profil im MII-Modul Onkologie, Arbeitstitel MII_PR_Onko_Therapieziel, abgeleitet aus OnkoTherapyGoal.

Es gibt im MII-Modul kein Goal-Profil und kein Element, das ein Behandlungsziel trägt. Die Überleitung ist daher eine echte Neuaufnahme, keine Erweiterung. Sie bringt fünf Fähigkeiten in den Kerndatensatz, die dort heute fehlen:

1. **Zielart** (Goal.category, ValueSet onko-therapy-goal-type): Heilung, Lebensverlängerung, Symptomkontrolle, Lebensqualität, Funktionserhalt. Mit ConceptMap auf SNOMED-CT-Zielzustände; die Beziehungsqualität ist ehrlich dokumentiert, einschließlich des unmatched bei Funktionserhalt. *Folgaufgabe für die finale Onko-Spezifikation (nicht für dieses Dokument): eine Tabelle mit Anwendungsbeispielen je Zielart.*
2. **Zielwert** (Goal.target): Zielgröße, angestrebter Wert, Frist. Der Anschluss an die Leitlinienversionierung ist in ADR-0023 geregelt.
3. **Zielerreichung** (Goal.lifecycleStatus × Goal.achievementStatus): Warum die Zielverfolgung endet, und mit welchem Grad. Die Statuskonvention ist bewusst restriktiv. Zugelassen sind nur die vier **Zustands-Codes** in-progress, achieved, not-achieved und not-attainable; completed im Lebenszyklus nur bei Erfolg. Nicht zugelassen sind die fünf **Trajektorie-Codes** improving, worsening, no-change, sustaining und no-progress: Goal.achievementStatus ist 0..1 und führt keine Historie, und die Codes definieren keinen Bezugspunkt — es bliebe offen, ob gegen Baseline, Nadir oder Vorwert verglichen wird. Verlauf und Ansprechen gehören deshalb in die zeitgestempelten Ergebnis-Observations (RECIST, MII_PR_Onko_Verlauf), die ihren Bezug selbst definieren (ADR-0018).
4. **Zielakzeptanz** (goal-acceptance, goal-reasonRejected): der Shared-Decision-Kern. Die Akzeptanz wohnt am Ziel, nicht am Plan und nicht an der Maßnahme.
5. **Zielbeziehung** (goal-relationship): predecessor/successor für die zeitliche Journey, replacement für die Intentions-Pivotierung kurativ → palliativ.

Anschluss an Bestehendes: Goal.addresses referenziert mii-pr-onko-diagnose-primaertumor. Goal.outcomeReference referenziert MII_PR_Onko_Verlauf bzw. MII_PR_Onko_Residualstatus — beide existieren im Modul bereits und werden durch die Überleitung erstmals **zielgebunden** auswertbar. Das ist der konkrete Mehrwert für die Sekundärnutzung: Ein Verlaufsbefund allein sagt, wie der Tumor steht; erst die Zielbindung sagt, ob das Behandlungsziel erreicht wurde.

Offen: Verhältnis von Goal.priority zu MII_EX_MTB_Empfehlung_Prioritaet. Beide drücken Priorität aus, aber an verschiedenen Objekten (Ziel vs. Empfehlung). Eine Doppelung ist inhaltlich vertretbar, muss aber bewusst entschieden werden.

4.2 Behandlungsepisode (EpisodeOfCare) → Weg A

Ziel: neues Profil im MII-Modul Onkologie, Arbeitstitel MII_PR_Onko_Behandlungsepisode, abgeleitet aus OnkoBehandlungsepisode.

Auch hier kein Pendant. Das MII-Modul bildet Behandlungsabschnitte heute nur implizit ab — über Procedure.performed an systemischer Therapie bzw. Strahlentherapie. Damit ist ein Abschnitt so lang wie seine Prozedur; ein sektorenübergreifend fortgeführter Abschnitt ist nicht darstellbar.

Das Profil bringt mit:

- **Episodenart** (type, extensible aus episodenart): systemische Therapielinie, lokoregionale Behandlungslinie, Diagnostiklinie, Active Surveillance, Watchful Waiting.
- **Intention** (onko-therapy-intent) als für jede Episodenart bestimmbares Merkmal, nicht nur für therapeutische — beschränkt auf kurativ, palliativ und supportiv; die **Stellung zur Operation** (neoadjuvant, adjuvant ...) ist ein eigenes Kontext-Merkmal daneben (6.2).
- **Behandlungsmodalität** (onko-modalitaet) als eigenes Merkmal neben der Episodenart, mehrfach belegbar (Radiochemotherapie).
- **EnLiST-Linienanzählung** (enlist-lot, enlist-line-segment, enlist-countable) nach dem ESMO-Konsens 2026: Eine Therapielinie ist ein fachliches Kontinuum, das organisatorisch in mehrere Episoden zerfällt, weil EpisodeOfCare organisationsgebunden ist. Genau eine führende Episode je Linie trägt die Designation; ausführende Einrichtungen dokumentieren Segmente mit gemeinsamer Linien-Id (ADR-0025).

Zwei Abstimmungspunkte:

Erstens der Begriff. MII_PR_MTB_Behandlungsepisode besetzt denselben Namen für eine ClinicalImpression. Beide Konzepte sind legitim und beide werden gebraucht, aber sie dürfen nicht denselben Namen tragen. Vorschlag: Der MTB-Begriff bezeichnet die Fallvorstellung, unser Begriff den Versorgungsabschnitt; eine der beiden Bezeichnungen wird angepasst. Die Entscheidung liegt bei den Modulverantwortlichen, nicht bei uns.

Zweitens der Andockpunkt der EnLiST-Extensions. Die Extensions enlist-lot und enlist-line-segment sind bewusst mit **zwei Kontexten** definiert: EpisodeOfCare **und** Procedure. Damit können sie auch ohne das neue Episoden-Profil an MII_PR_Onko_Systemische_Therapie angebracht werden. Das ist die Rückfallebene, falls die Aufnahme eines EpisodeOfCare-Profiles im Modul nicht konsensfähig ist — mit dem Preis, dass die Linie dann wieder an die Prozedur gebunden ist und die sektorenübergreifende Fortführung verloren geht. Wir empfehlen den Episoden-Weg und führen den Prozedur-Kontext als Kompatibilitätsbrücke, nicht als Alternative.

4.3 Empfehlungsplan und Tumorboard-Empfehlungen → Weg B

Ziel: Ergänzung der bestehenden MII-Profil. Es entsteht **kein** neues CarePlan-Profil für den Empfehlungsplan.

Leitfaden-Artefakt	Bestehendes MII-Profil	Ergänzung
OnkoCarePlan mit intent = proposal/plan (Empfehlungsplan)	MII_PR_Onko_Tumorkonferenz	goal (Referenz auf Therapieziel), extension[workflow-episodeOfCare], extension[onko-therapy-intent], extension[onko-careplan-custodian]
TumorboardMedicationRequest	MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Medikation	extension[enlist-change], statusReason als Pflicht-unterstütztes Element
TumorboardServiceRequest	MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Operation	extension[request-statusReason]
Multimodale Empfehlung (ADR-0021)	MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Kombinationstherapie	keine Ergänzung nötig

Die Tumorboard-Kennzeichnung über category mit LOINC 85232-7 (*Tumor board Consult note*), die der Leitfaden an seinen Request-Profilen verpflichtend führt, wird bei der Überleitung **nicht** mit übernommen: Im MII-Modul ergibt sich der Tumorboard-Kontext bereits aus der Zugehörigkeit zum Tumorkonferenz-CarePlan. Die Kennzeichnung ist im Leitfaden nötig, weil dort ein Request auch ohne Planbezug auftreten kann; im Kerndatensatz wäre sie Redundanz.

Abstimmung mit MTB ist hier zwingend. Jede Ergänzung an MII_PR_Onko_Tumorkonferenz erbt MII_PR_MTB_Therapieplan mit. Da wir ausschließlich optionale Elemente ergänzen (0..*, 0..1), ist die Änderung abwärtskompatibel — bestehende MTB-Instanzen bleiben gültig. Diese Zusage ist Teil des Einreichungsvorschlags und vor Einreichung zu verifizieren.

4.4 Behandlungs- und Diagnostikplan → Weg D

Ziel: Einreichung eines eigenen CarePlan-Profiles bei **ISiK**; perspektivisch Überführung in die **Kernprofile**; das MII-Modul Onkologie leitet in beiden Stufen eine onkologische Ausprägung davon ab.

Der Behandlungsplan ist der episodenspezifische Plan **tatsächlich erbrachter** Versorgung — basedOn auf den Empfehlungsplan, verknüpft mit der Behandlungsepisode über workflow-episodeOfCare, verfolgend das Episodenziel. Er ist damit ein versorgungsnahes Artefakt, getragen vom KIS oder von onkologischer Spezialsoftware wie Tumordokumentationssystemen, und gehört seiner Natur nach in die ISiK-Schiene; seine onkologische Ausprägung gehört in den Kerndatensatz.

Der **diagnostische Abschnitt** ist damit bereits abgedeckt. Der Leitfaden hat sein früheres Profil DiagnosticCarePlan aufgegeben und unterscheidet Diagnostik von Therapie seither über

CarePlan.category, gebunden an das ValueSet onko-care-plan-phase (261004008 Diagnostic intent, 262202000 Therapeutic intent, 363676003 Palliative intent). Das ist dieselbe Lösung, die auch für die Überleitung trägt: ein Profil, zwei Ausprägungen über die Kategorie — ergänzt um die Episodenart „Diagnostiklinie“ an der zugehörigen Episode.

Die Stufung ISiK → Kernprofile ist Teil des Zielbilds. ISiK ist der richtige *erste* Kanal, weil dort die Krankenhaus-Implementierungen entstehen, an denen sich das Profil bewähren muss. Ein Planungsartefakt, das Terminvergabe und Apothekenanbindung trägt, gehört danach aber nicht dauerhaft in eine sektorspezifische Spezifikation: Sobald die Praxistauglichkeit belegt ist, ist die Überführung auf die Ebene der **Kernprofile** anzustreben, damit auch der ambulante Sektor, Reha und die Vernetzungsstandards darauf aufsetzen können, ohne ISiK zu implementieren. Die MII-Ableitung zieht dann auf die Kernprofil-Fassung um. Praktisch heißt das für die jetzige Modellierung: Die ISiK-Einreichung darf keine Festlegungen treffen, die nur im stationären Kontext tragen — die Kernprofil-Fähigkeit ist von Beginn an mitzudenken, auch wenn die Überführung erst später ansteht.

Die Doppelung ISiK + MII ist bewusst: ISiK trägt das generische Muster, das MII-Modul die onkologische Verengung (addresses auf die Tumordiagnose, goal auf das onkologische Therapieziel, Aktivitäten auf die onkologischen Request- und Prozedur-Profile). Die MII-Ableitung ist damit an die ISiK-Aufnahme gebunden — das ist die einzige Abhängigkeit in diesem Plan, die außerhalb der MII-Governance liegt und deshalb früh adressiert werden muss.

Warum ISiK der richtige Kanal ist: krankenhauserneuerung Verwendung

Der Zweck des Behandlungsplans ist schlicht: **Erst mit ihm lassen sich die Therapien selbst direkt mitmodellieren.** Geplante Maßnahmen hängen als activity.reference am Plan, durchgeführte als activity.outcomeReference — und tragen über den Plan den Kontext, der ihnen einzeln fehlt: die Therapieintention, die Behandlungsepisode, das verfolgte Ziel und den Bezug auf den Board-Beschluss. Ohne dieses Dach sind Verordnung, Termin, Durchführung und Ergebnis lauter Einzelressourcen ohne gemeinsamen Halt.

Das ist ein operatives Erfordernis des laufenden Krankenhausbetriebs, kein Auswertungsbedarf — und genau deshalb geht das Profil zu ISiK und nicht allein in den Kerndatensatz. Die folgenden drei Verwendungen im KIS bzw. im Tumordokumentationssystem sind Ausprägungen dieses einen Punktes, keine drei eigenen Anforderungen:

Terminfindung für geplante diagnostische Maßnahmen. Der Diagnostikplan listet die Schritte des Diagnosepfads als Aktivitäten (activity.reference → ServiceRequest bzw. Appointment). Die Terminvergabe für Bildgebung, Biopsie und Befundbesprechung greift auf diese Liste zu: Was noch keinen Termin hat, ist offen; was terminiert ist, trägt einen Appointment-Bezug; das Ergebnis kommt über activity.outcomeReference (DiagnosticReport, Observation) zurück an

dieselbe Aktivität. Der Plan wird damit zur Arbeitsliste der Leitstelle, ohne dass ein zweites Planungsartefakt gepflegt werden muss. Für das Tumorboard ist derselbe Plan die Antwort auf die Frage, ob die Diagnostik vollständig ist — die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine belastbare Empfehlung ausgesprochen werden kann.

Terminfindung und Koordination geplanter therapeutischer Maßnahmen. Beim multimodalen Konzept — etwa neoadjuvante Systemtherapie, Operation, adjuvante Bestrahlung — hängt die Terminierung jedes Schritts von der Fertigstellung des vorigen ab. Der Behandlungsplan hält die Abfolge mit ihren Abhängigkeiten zusammen; die Zuordnung zur Behandlungsepisode über workflow-episodeOfCare sagt, welcher Abschnitt gerade läuft und welche Organisation ihn führt. Die Verlegung zwischen Abteilungen oder in die ambulante Weiterbehandlung bricht die Kette nicht, weil der Plan an der Episode hängt und nicht am Aufenthalt.

Grundlage einer Medikationsbestellung bei der Zentralapotheke. Die Zubereitung einer Zytostatika-Applikation in der Krankenhausapotheke setzt auf dem MedicationRequest auf, der als Aktivität im Behandlungsplan steht. Für die Apotheke sind dabei genau die Angaben entscheidend, die der Plan im Kontext trägt und die am isolierten Request fehlen würden: Protokoll und Zyklus über den Planbezug, Therapieintention und Behandlungsepisode über die Verknüpfungen, sowie der Umsetzungsstatus der Einzelmaßnahme — eine auf Patientenwunsch verworfene Empfehlung sollte möglichst nicht zubereitet werden. Der basedOn-Bezug auf den Empfehlungsplan des Tumorboards macht zusätzlich nachvollziehbar, auf welchen Board-Beschluss die Bestellung zurückgeht; das ist im Zytostatika-Kontext auch haftungsrelevant.

In allen drei Fällen ist es dasselbe Profil und dieselbe Mechanik; unterschiedlich sind nur die Kategorie und die referenzierten Maßnahmen. Sie ist für die Onkologie exemplarisch, aber nicht onkologiespezifisch — jede terminierte, mehrstufige Behandlung braucht sie. Genau deshalb gehört das generische Profil nach ISiK und nur seine onkologische Verengung in den Kerndatensatz.

4.5 Tumordiagnose (Condition) → Weg C

Hier ist die Überleitung bereits vollzogen. Der Leitfaden führte zur Ballot-Fassung noch ein eigenes Profil OnkoCondition, das unverändert von mii-pr-onko-diagnose-primaertumor ableitete und nichts hinzufügte außer dem Profil-Status. Es wurde im Zuge der Kommentierung gestrichen; sämtliche Referenzen — Goal.addresses, CarePlan.addresses, EpisodeOfCare.diagnosis.condition — zeigen seither über targetProfile **direkt auf das MII-Diagnoseprofil**.

Damit ist an dieser Stelle nichts mehr zu tun, und der Leitfaden demonstriert bereits das Muster, das die übrige Überleitung anstrebt: kein eigenes Artefakt, wo das MII-Modul eines führt.

Dasselbe gilt für die Ergebnis-Referenzen: MII_PR_Onko_Verlauf und MII_PR_Onko_Residualstatus existieren im Modul und werden lediglich zum Referenzziel von Goal.outcomeReference.

4.6 Was im Leitfaden verbleibt → Weg E

Artefakt	Begründung
Logisches Modell TherapiezielDreieck	Fachliche Normalform und Lesehilfe des Leitfadens; das MII-Modul führt sein eigenes MII_LM_Onko
Szenario-Bundles (mCRC palliativ, Mamma neoadjuvant, abweichende Szenarios)	Beispielinstanzen; Kerndatensätze führen eigene Testdaten
Kapitel zu weiteren Entitäten (Diabetes, Asthma, CED, Rheumatoide Arthritis)	Belegen die Übertragbarkeit des Dreiecks über die Onkologie hinaus — außerhalb des onkologischen Moduls
ePA-Dokumentenarchitektur, CPG-on-FHIR-Anbindung, IPS/EPS-Brücke	Liegen oberhalb bzw. seitlich des Kerndatensatzes
Zweisprachigkeit (de/en) mit Übersetzungsdateien	Leitfaden-Eigenschaft

5 Datenpunkt-Überleitung im Einzelnen

Die folgende Tabelle führt jeden Datenpunkt des logischen Modells TherapiezielDreieck. Spalte „MII-Ziel“ nennt den Landeplatz nach vollzogener Überleitung.

5.1 Behandlungsepisode

#	Datenpunkt	FHIR im Leitfaden	MII-Ziel	Weg
1	Patientin/ Patient	EpisodeOfCare .patient	EpisodeOfCare .patient → MII Patient	A
2	Art der Episode	EpisodeOfCare .type (VS episodenart)	neues Element; ConceptMap ← mii-cs-onko- therapie-typ	A
3	Intention (kurativ, palliativ, supportiv)	extension[onk o-therapy- intent].hauptin tention	neues Element; ConceptMap ↔ mii-cs-onko- intention (6.2)	A
3a	Stellung zur Operation (neoadjuvant, adjuvant, intraoperativ, additiv)	extension[onk o- behandlungs- kontext] an der Maßnahme	deckt mii-cs- onko- therapie- stellungzurop (A/N/I/Z) ab	A
4	Behandlungsp hase	extension[onk o-therapy-	neues Element (SNOMED)	A

#	Datenpunkt	FHIR im Leitfaden	MII-Ziel	Weg
		intent].phase	Induktion/Konsolidierung/Intensivierung/Erhaltung)	
5	Behandlungsmodalität	extension[onko-modalitaet]	neues Element; ConceptMap ← mii-cs-onko-therapie-typ	A
6	Zeitraum	EpisodeOfCare.period	neues Element; fachlich verwandt mit Procedure.performed an MII_PR_Onko_Systemische_Therapie	A
7	Status	EpisodeOfCare.status	neues Element; Beendigungsgr und über mii-cs-onko-therapie-ende-grund anschließbar	A
8	Statusverlauf	EpisodeOfCare.statusHistory	neues Element	A
9	Verantwortliche Organisation	EpisodeOfCare.managingOrganization	neues Element	A
10	Fallverantwortliche Person	EpisodeOfCare.careManager	neues Element	A
11	Behandlungsteam	EpisodeOfCare.team	neues Element	A
12	Diagnosebezug	EpisodeOfCare.diagnosisCondition	Referenz auf mii-pr-onko-diagnose-primaertumor	A/C
13	Zugrundeliegende Anforderung	EpisodeOfCare.referralRequest	neues Element	A
14	Zugrundeliegende Medikationsverordnung	extension[onko-therapy-line-medication-request]	neues Element; Referenzziel MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Medikation	A
15	EnLiST-Designation	extension[enlist-lot]	neues Element;	A

#	Datenpunkt	FHIR im Leitfaden	MII-Ziel	Weg
	(Setting, Linie X, Modifikation Y, Notation, Linien-Id)		alternativ an MII_PR_Onko_Systemische_Therapie	
16	EnLIST-Segment-Marker	extension[enlist-line-segment]	neues Element	A
17	EnLIST-Zählstatus	extension[enlist-countable]	neues Element	A

5.2 Therapieziel

#	Datenpunkt	FHIR im Leitfaden	MII-Ziel	Weg
18	Zielebene (übergeordnet / Episodenziel)	implizit über den Plan-Graphen	bleibt implizit – bewusst kein eigenes Element (ADR-0015)	A
19	Zielart	Goal.category (VS onco-therapy-goal-type)	neues Element + ValueSet + SNOMED-ConceptMap	A
20	Zielbeschreibung	Goal.description	neues Element	A
21	Adressierte Erkrankung	Goal.addresses	Referenz auf mii-pr-onko-diagnose-primaertumor	A/C
22	Zielgröße	Goal.target.measure	neues Element; Leitlinienbindung nach ADR-0023	A
23	Zielwert-Ausprägung	Goal.target.detail[x]	neues Element	A
24	Frist	Goal.target.due[x]	neues Element	A
25	Ergebnis	Goal.outcomeReference	Referenz auf MII_PR_Onko_Verlauf, MII_PR_Onko_Residualstatus	A/C
26	Lebenszyklus-Status	Goal.lifecycleStatus	neues Element	A
27	Erreichungsgrad	Goal.achievementStatus	neues Element; Brücke zu mii-cs-onko-verlauf-gesamtbeurteilung	A

#	Datenpunkt	FHIR im Leitfaden	MII-Ziel	Weg
			lung	
28	Zielakzeptanz (wer, Status)	extension[goal-acceptance]	neues Element; HL7-Standard-Extension, keine eigene Definition nötig	A
29	Ablehnungsgrund	extension[goal-reasonRejected]	neues Element; Brücke zu mii-cs-onko-therapieabweichung	A
30	Zielbeziehung (Art, bezogenes Ziel)	extension[goal-relationship]	neues Element; HL7-Standard-Extension	A
31	Priorität	Goal.priority	neues Element; Abgrenzung zu MII_EX_MTB_Empfehlung_Priorität klären	A
32	Verfasser	Goal.expressedBy	neues Element	A
33	Zielbeginn	Goal.start[x]	neues Element	A

5.3 Versorgungsplan

#	Datenpunkt	FHIR im Leitfaden	MII-Ziel	Weg
34	Planart Empfehlung	CarePlan.intent = proposal/plan	MII_PR_Onko-Tumorkonferenz (vorhanden)	B
35	Planart Behandlung	CarePlan.intent = plan/order	ISiK-Profil, später Kernprofile, MII-Ableitung	D
35a	Diagnostischer vs. therapeutischer Abschnitt	CarePlan.category (VS onko-care-plan-phase)	Ergänzung an Tumorkonferenz; ersetzt das entfallene Profil DiagnosticCare Plan	B
36	Plan-Status	CarePlan.status	vorhanden in Tumorkonferenz	B
37	Verfolgtes Ziel	CarePlan.goal	Ergänzung an	B

#	Datenpunkt	FHIR im Leitfaden	MII-Ziel	Weg
			Tumorkonferenz	
38	Bezug zur Behandlungsepisode	extension[workflow-episodeOfCare]	Ergänzung an Tumorkonferenz	B
39	Custodian	extension[onco-careplan-custodian]	Ergänzung an Tumorkonferenz (R5-Backport aus MCC)	B
40	Therapieintention am Plan	extension[onco-therapy-intent]	Ergänzung an Tumorkonferenz	B
41	Basiert auf (Behandlung → Empfehlung)	CarePlan.baseOfOn	am ISiK-/MII-Behandlungsplan	D
42	Adressierte Erkrankung	CarePlan.addresses	vorhanden in Tumorkonferenz	C
43	Maßnahme: Medikations-Anforderung	TumorboardMedicationRequest	MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Medikation	B
44	Maßnahme: Prozedur-Anforderung	TumorboardServiceRequest	MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Operation	B
45	Maßnahme: multimodale Kombination	RequestGroup (ADR-0021)	MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Kombinationstherapie	C
46	Umsetzungsstatus der Einzelempfehlung	MedicationRequest.status / ServiceRequest.status	vorhanden	C
47	Statusgrund der Einzelempfehlung	MedicationRequest.statusReason, ServiceRequest.extension[request-statusReason]	Ergänzung; ersetzt fachlich das binäre activity.detail.statusReason	B
48	EnLiST-Änderungstyp	extension[enlist-change] am MedicationRequest	Ergänzung an Therapieempfehlung_Medikation	B
49	Durchführung (Vollzugslink)	CarePlan.activity.outcomeRef	MII_PR_Onko_Systemische_T	C

#	Datenpunkt	FHIR im Leitfaden	MII-Ziel	Weg
		erence	herapie, _Operation, _Strahlenthera pie, _Systemische_ Therapie_Medi kation	
50	Zugrunde liegende PlanDefinition	CarePlan.insta ntiatesCanonic al	verbleibt im Leitfaden (CPG-Schicht)	E

5.4 Tumordiagnose

#	Datenpunkt	FHIR im Leitfaden	MII-Ziel	Weg
51	Tumordiagnos e insgesamt	targetProfile auf mii-pr- onko- diagnose- primaertumor an Goal.addresse s, CarePlan.addr esses, EpisodeOfCare .diagnosis.con dition	bereits das MII-Profil — kein eigenes Artefakt mehr	C

6 Terminologie-Überleitung und semantische Brücken

6.1 Zu übernehmende Terminologie-Artefakte

Artefakt	Typ	Konzepte	Bindung	Weg
onko-therapy- goal-type	CodeSystem + ValueSet	heilung, lebensverlaen gerung, symptomkontr olle, lebensqualitae t, funktionserhal t	extensible an Goal.category	A
episodenart	CodeSystem + ValueSet	systemische- therapielinie, lokoregionale- behandlungsli nie, diagnostiklinie , active-	extensible an EpisodeOfCare .type	A

Artefakt	Typ	Konzepte	Bindung	Weg
		surveillance, watchful- waiting		
enlist-lot- setting	CodeSystem + ValueSet	eLoT, aLoT, iLoT	required in enlist- lot.setting	A
enlist-change- type	CodeSystem + ValueSet	new, modified, same	required in enlist-change	A
enlist- countable	CodeSystem + ValueSet	counted, not- counted	required in enlist- countable	A
onko-therapy- intent	ValueSet (SNOMED CT)	373808002 Curative · 363676003 Palliative · 399707004 Supportive	extensible in onko-therapy- intent.hauptin- tention	A
onko-service- request- kontext	ValueSet (SNOMED CT)	373847000 Neoadjuvant · 373846009 Adjuvant · 277671009 Intraoperative · 260364009 Additive · 255470001 Local · 264931009 Symptomatic · 129428001 Preventive · 261002007 Definitive · 103390000 Elective · 25876001 Emergency	required in onko- behandlungs- kontext	A
onko-care- plan-phase	ValueSet (SNOMED CT)	261004008 Diagnostic intent · 262202000 Therapeutic intent · 363676003 Palliative intent	in CarePlan.categ- ory	A
onko-goal- start-event	ValueSet (SNOMED CT + HL7)	HL7 goal-start- event plus 264908009 Post-radiation · 262502001 Post-	example in Goal.start[x]	A

Artefakt	Typ	Konzepte	Bindung	Weg
		chemotherapy · 262061000 Postoperative period u. a.		
onko-therapy- phase	ValueSet (SNOMED CT)	450827009 Induction · 816151001 Consolidation · 1254741007 Intensification · 1345242003 Maintenance	extensible in onko-therapy- intent.phase	A
onko- behandlungsmoda- litaet	ValueSet (SNOMED CT)	385786002 Chemotherapy care · 315601005 Ambulatory chemotherapy · 385798007 Radiation therapy care · 76334006 Immunological therapy · 169413002 Hormone therapy · 387713003 Surgical procedure	example in onko- modalitaet	A
ConceptMapO nkoTherapyGo alTypeSct	ConceptMap	5 Zielarten → SNOMED- Zielzustände; Beziehungsqu alität equivalent / relatedto / unmatched	—	A

Neu zu erstellen im Zuge der Überleitung (drei ConceptMaps, die es heute in keinem der beiden Artefakte gibt):

Neue ConceptMap	Richtung	Zweck
episodenart ← mii-cs- onko-therapie-typ	MII → Leitfaden	WW, AS, WS, OP, ST auf Episodenarten abbilden
onko- behandlungsmodalitaet ← mii-cs-onko-therapie-typ	MII → Leitfaden	CH, HO, IM, ZS, SZ und die Kombinationscodes auf Modalitäten abbilden
onko-therapy-intent ↔ mii-cs-onko-intention + mii-cs-onko-therapie- stellungzurop	bidirektional	Ein-Achsen- auf Zwei- Achsen-Kodierung abbilden (siehe 6.2)

6.2 Intention und Kontext trennen

Hier laufen beide Seiten auf dasselbe Modell zu — das ist die wichtigste inhaltliche Korrektur gegenüber dem bisherigen Stand des Leitfadens.

Das MII-Modul kodiert oBDS-basiert auf **zwei** Achsen:

mii-cs-onko-intention: K kurativ · P palliativ · D diagnostisch · R Revision/Komplikation · S Sonstiges · X fehlende Angabe · O lokal kurativ bei Oligometastasierung mii-cs-onko-therapie-stellungzurop: O ohne Bezug · A adjuvant · N neoadjuvant · I intraoperativ · Z additiv · S Sonstiges

Für den Leitfaden ist entschieden, dass **neoadjuvant und adjuvant ebenfalls zum Kontext gehören und nicht zur Intention**. Die Begründung ist fachlich, nicht formal: Beide Begriffe sagen nichts darüber, *was* erreicht werden soll — eine neoadjuvante Therapie ist in aller Regel kurativ intendiert —, sondern *wo im Behandlungsablauf* die Maßnahme steht, nämlich in ihrer Stellung zur Operation. Sie sind deshalb mit der Intention **kombinierbar**, nicht zu ihr alternativ. Sie in eine gemeinsame Liste mit kurativ und palliativ zu stellen, erzwingt eine Entscheidung, die es fachlich nicht gibt, und macht die häufigste Angabe — „kurativ, neoadjuvant“ — unausdrückbar.

Die Intention des Leitfadens reduziert sich damit auf **kurativ, palliativ und supportiv**; die Stellung zur Operation wird ein eigenes Merkmal und deckt sich mit mii-cs-onko-therapie-stellungzurop.

Im Leitfaden vollzogen. Das ValueSet onko-therapy-intent führt die Codes 373847000 (*Neoadjuvant intent*) und 373846009 (*Adjuvant - intent*) nicht mehr; sie stehen in onko-service-request-kontext, gebunden über die Extension onko-behandlungs-kontext an ServiceRequest, Procedure, MedicationRequest und MedicationAdministration. Damit ist die Kontext-Achse dort verankert, wo die Stellung zur Operation entsteht — an der einzelnen Maßnahme, nicht an der Episode.

Bei der Gelegenheit korrigiert wurde auch die Herkunftsangabe des Intentions-ValueSets: Es nannte 362961001 | Procedure by intent als Quellhierarchie. Gegen SNOMED CT International 20260501 geprüft — mit Kontrollfällen, die die Funktionsfähigkeit des Subsumptions-Endpunkts belegen — subsumiert dieser Code **keinen** der geführten Codes, auch *Curative* nicht. Tatsächlich liegen sie unter 362981000 | Qualifier value.

Terminologischer Befund, der die Trennung stützt. Intention und Kontext liegen beide unter 362981000 | Qualifier value — deshalb lassen sich neoadjuvant und adjuvant ohne Hierarchiebruch zwischen den Listen verschieben, und deshalb ist die Grenze zwischen ihnen fachlich zu ziehen, nicht terminologisch erzwungen. Dass sie ausfranst, zeigt 129428001, das wörtlich „*Preventive - procedure intent*“ heißt und in der Kontextliste steht. Die **Modalität** dagegen liegt unter 71388002 | Procedure — einer anderen obersten Hierarchie. Modalität ist

eine Handlung, Intention und Kontext sind Qualifier zu einer Handlung; die drei Achsen sind damit nicht nur fachlich, sondern terminologisch verschieden.

Folge für die Überleitung: Die Brücke wird damit nahezu trivial. Das MII-Modul führt mit mii-cm-onko-intention-sct bereits eine ConceptMap seiner Intensionscodes nach SNOMED CT und mappt K → 373808002 und P → 363676003 — also genau auf zwei der drei verbleibenden Codes. Zu ergänzen bleibt nur die Behandlung der Codes, die jeweils nur eine Seite kennt:

Code	Seite	Behandlung
399707004 Supportive	nur Leitfaden	im MII-Modul über die extensible Bindung ergänzbar
D diagnostisch	nur MII	im Leitfaden über die Episodenart „Diagnostiklinie“ ausgedrückt, nicht über die Intention
R Revision/Komplikation	nur MII	kein Intensionsbegriff im Sinne des Leitfadens; als unmatched zu führen
O lokal kurativ bei Oligometastasierung	nur MII	auf 373808002 mit Beziehungsqualität wider — der Zusatz geht in der Rückrichtung verloren
X fehlende Angabe	nur MII	über dataAbsentReason statt über einen Intensionscode

6.3 Brücke Episodenart und Modalität: eine Liste gegen zwei Merkmale

mii-cs-onko-therapie-typ enthält in **einer** Liste:

- Modalitäten: CH, HO, IM, ZS, SZ und die Kombinationen CI, CZ, CIZ, IZ
- Versorgungsstrategien: WW (Watchful Waiting), AS (Active Surveillance), WS (Wait and see)
- Lokoregionale Verfahren: OP, ST
- Negativaussage: KW (keine weitere tumorspezifische Therapie empfohlen)

Der Leitfaden trennt das bewusst in **Episodenart** (was für ein Abschnitt) und **Modalität** (womit behandelt wird), weil die Merkmale unabhängig variieren: Eine systemische Therapielinie kann Chemotherapie *und* Immuntherapie sein, und Active Surveillance ist keine Modalität, sondern das Ausbleiben einer Behandlung bei aktiver Überwachung.

Die Kombinationscodes CI, CZ, CIZ, IZ sind dafür der beste Beleg: Sie existieren nur, weil eine Ein-Listen-Kodierung Mehrfachbelegung nicht zulässt. Im Leitfaden entfallen sie — die Episode trägt dann zwei bzw. drei Modalitäts-Extensions. Die Konsistenz zwischen Kombinationscode und Mehrfachbelegung wird über **FHIR-Invarianten** abgesichert, nicht über Konvention.

Empfehlung: mii-cs-onko-therapie-typ bleibt für die Therapieempfehlung unverändert (oBDS-Bindung). Das neue Episoden-Profil führt Episodenart und Modalität getrennt, mit

ConceptMaps in beide Richtungen. KW bildet keine Episode ab, sondern deren Ausbleiben — dieser Code wird in der ConceptMap ausdrücklich als unmatched geführt statt künstlich zugeordnet.

6.4 Brücke Zielerreichung und Verlauf

mii-cs-onko-verlauf-gesamtbeurteilung (V, T, K, P, D, B, R, Y, U, X) beschreibt den **Tumorstatus**; Goal.achievementStatus beschreibt die **Zielerreichung**. Das ist nicht dasselbe, hängt aber zusammen: Vollremission bei kurativem Ziel bedeutet achieved, Progression bei kurativem Ziel bedeutet in der Regel den Pivot auf ein palliatives Ziel mit not-achieved und replacement-Beziehung.

Eine ConceptMap wäre hier **falsch**, weil die Zuordnung von der Zielart abhängt: Progression bei einem Symptomkontroll-Ziel sagt nichts über die Zielerreichung aus. Stattdessen bleibt die Verknüpfung referenziell — Goal.outcomeReference zeigt auf die Verlaufs-Observation, die Interpretation bleibt beim auswertenden System. Das ist bewusst und in ADR-0018 begründet.

6.5 Brücke Statusgrund und Therapieabweichung

Das MII-Modul führt activity.detail.statusReason gebunden an mii-cs-onko-therapieabweichung mit genau drei Codes: J / N / U. Es beantwortet damit die Frage „*Wurde auf Patientenwunsch abgewichen?*“ — aber nicht „*Warum?*“.

Der Leitfaden nutzt dieselbe Stelle für den fachlichen Grund (Patientenwunsch, Komorbidität, Progress) an MedicationRequest.statusReason bzw. ServiceRequest.extension[request-statusReason]. Für die nächste Tumorboard-Runde ist dieser Grund die eigentlich versorgungsrelevante Information.

Empfehlung: Beides nebeneinander führen. activity.detail.statusReason bleibt oBDS-konform am Tumorkonferenz-Plan; der fachliche Grund kommt am Request hinzu. Doppelpflege entsteht nicht, weil die Ebenen verschieden sind — Plan-Ebene gegen Einzelmaßnahmen-Ebene.

6.6 EnLiST: ohne Pendant im MII-Modul

Die vier EnLiST-Artefakte haben im MII-Modul keinerlei Entsprechung. mii-cs-onko-therapie-ende-grund ist das Nächstliegende und für die Zähllogik nutzbar: P (Abbruch wegen Progress) ist der EnLiST-Trigger für eine *New LoT*, R und W (Dosisreduktion, Substanzwechsel) für eine *Modified LoT*, V (Patient verweigert weitere Therapie) für einen nicht-progressionsbedingten Abbruch. Eine ConceptMap enlist-change-type ← mii-cs-onko-therapie-ende-grund ist damit möglich und sollte Teil der Überleitung sein, auch wenn sie nicht vollständig determiniert — der Ende-Grund allein trägt die Zählentscheidung nicht, er indiziert sie nur.

Reifegrad-Hinweis, der in den Einreichungsunterlagen stehen muss: EnLiST ist ein bis zum Abschluss des ESMO-Road-Testings experimentelles Konzept. Sein Nutzen liegt in der Sekundärnutzung (Auswertung, CDS, Studieneinschluss), nicht in der Versorgung. Die Überleitung sollte die EnLiST-Artefakte deshalb als optional und ausdrücklich experimentell einbringen, nicht als Pflichtbestandteil des Kerndatensatzes. Das ist keine Schwäche des Konzepts, sondern die ehrliche Einordnung seines Reifegrads.

7 Was der Leitfaden dem MII-Modul hinzufügt

Für die Bewertung des Nutzens durch den Auftraggeber, in der Reihenfolge des Gewichts:

1. **Das Behandlungsziel als eigenständige, dem Plan vorausgehende Entität.** Heute lässt sich im Kerndatensatz dokumentieren, *was getan wurde*, aber nicht, *wozu*. Die Intention hängt als Attribut an der einzelnen Prozedur; ein patientenbezogenes, über Episoden hinweg verfolgtes Ziel existiert nicht.
2. **Die Zielakzeptanz als strukturiertes Element.** Shared Decision Making ist im Kerndatensatz derzeit auf ein Ja/Nein/Unbekannt am Empfehlungspunkt reduziert. Wer welchem Ziel mit welcher Begründung zugestimmt oder widersprochen hat, ist nicht abbildbar — obwohl genau das die Grundlage für die Bewertung von Versorgungsqualität und Patientenpräferenz wäre.
3. **Der Behandlungsabschnitt als organisationsübergreifendes Kontinuum.** Die Bindung des Abschnitts an die Prozedur bricht an jeder Sektorengrenze. Das Episoden-Profil mit gemeinsamer Linien-Id hält eine Therapielinie über den Wechsel von der Klinik in die niedergelassene Praxis zusammen.
4. **Die Zielbindung vorhandener Ergebnisdaten.** Verlauf und Residualstatus liegen bereits im Modul. Erst die Verknüpfung mit einem Ziel macht aus einem Tumorstatus eine Aussage über Zielerreichung — ohne ein einziges neues Ergebnis-Datenelement.
5. **Die Therapielinienzählung nach europäischem Konsens.** Voraussetzung für vergleichbare Real-World-Auswertungen und für linienspezifische Zulassungs- und Erstattungsentscheidungen.
6. **Die Trennung von Episodenart und Modalität.** mii-cs-onko-therapie-typ führt heute Chemotherapie, Watchful Waiting und die Kombinationscodes CI, CZ, CIZ, IZ in einer Liste. Die Kombinationscodes existieren nur, weil eine Ein-Listen-Kodierung Mehrfachbelegung nicht zulässt — sie sind der Preis der Vermischung, nicht ihr Zweck. Mit getrennten Merkmalen entfallen sie, und eine Radiochemotherapie trägt schlicht zwei Modalitäten.

8 Umsetzungsplan

Zieltermin für die vollzogene Überleitung: **Ende 2027.**

AP	Arbeitspaket	Voraussetzung	Ergebnis
1	Einreichung als ein geschlossener Kommentierungskommentar in die laufende Kommentierung, mit diesem Dokument als Grundlage (Weg A und B)	laufende Kommentierungsfrist	eingereichter Kommentar mit Vorgangsnummer
2	Abstimmung mit MII AG Onkologie: Aufnahme Therapieziel + Behandlungsepisode	parallel zu AP 1	Grundsatzentscheidung zur Aufnahme
3	Abstimmung mit MII-Modul MTB: Begriff „Behandlungsepisode“, Abwärtskompatibilität der Tumorkonferenz-Ergänzung, Verhältnis der Prioritäts-Extensions	AP 1	abgestimmte Änderungszusage
4	Einreichung des Behandlungsplan-Profils bei ISiK	unabhängig, früh starten	ISiK-Aufnahmeentscheidung
5	Terminologie-Entscheidung: Trennung Episodenart/Modalität gegenüber mii-cs-onko-therapietyp	AP 2, TC Terminologien	Festlegung, Grundlage für AP 6
6	Erstellung der vier ConceptMaps (3 neu + EnLiST-Änderungstyp ← Ende-Grund)	AP 5	lauffähige, validierte ConceptMaps
7	Begleitung der Disposition; Nachreichen von Profilmaterial, wo der Kommentar es	AP 1–3, 6	disponierter Kommentar

AP	Arbeitspaket	Voraussetzung	Ergebnis
	verlangt		
8	Modul-Release abwarten; Analyse und Pinning im Leitfaden auf die Release-Fassung nachziehen	AP 7	sushi-config.yaml, grüner Build
9	Ableitung des onkologischen Behandlungsplan-Profils vom ISiK-Profil	AP 4, 8	MII-Profil
10	Rückbau im Leitfaden: übergeleitete Artefakte durch Referenzen auf die MII-Fassung ersetzen	AP 8, 9	Leitfaden-Release ohne Duplikate – Ende 2027
11	Nach Bewährung im Krankenhausbetrieb: Überführung des Behandlungsplan-Profils in die Kernprofile; MII-Ableitung auf die Kernprofil-Fassung umstellen	AP 9, Praxiserfahrung aus ISiK-Umsetzungen	Kernprofil, nachgezogene MII-Ableitung (nach 2027)

Kritisch ist AP 1, weil es an die Kommentierungsfrist gebunden ist: Wird sie verpasst, verschiebt sich die gesamte Kette um einen Modulzyklus und der Zieltermin Ende 2027 ist nicht mehr zu halten. AP 4 (ISiK) ist der zweite kritische Strang, weil er außerhalb der MII-Governance liegt und AP 9 blockiert. AP 2, 4 und 5 laufen parallel.

9 Risiken und offene Entscheidungen

#	Risiko / Entscheidung	Wirkung	Vorschlag
1	Aufnahme eines EpisodeOfCare-Profils im MII-Modul nicht konsensfähig	Therapielinie fällt auf Prozedur-Bindung zurück, sektorenübergreifende Fortführung entfällt	Rückfallebene ist vorbereitet: EnLiST-Extensions sind auch für Procedure kontextualisiert
2	Begriffskollision „Behandlungsepisode“ mit MTB bleibt ungelöst	Zwei gleichnamige Artefakte mit verschiedener Semantik im selben Kerndatensatz	Vor Einreichung entscheiden (AP 4); eine der Bezeichnungen wird angepasst

#	Risiko / Entscheidung	Wirkung	Vorschlag
3	Die für ISiK 7.0 angedachte Aufnahme des Behandlungsplans verschiebt sich oder entfällt	Weg D bricht; das Profil müsste doch im MII-Modul geführt werden	Zusage für Version 7.0 liegt vor (3.3); Ausweichplan bleibt das eigenständige MII-Profil
4	Überführung in die Kernprofile erfolgt nie oder unter abweichender Modellierung	Zwei Behandlungsplan-Fassungen (ISiK und Kernprofil) mit Migrationsaufwand für die MII-Ableitung	ISiK-Einreichung von Beginn an sektorneutral halten (4.4); Überführung als Zielbild dokumentieren, nicht als Zusage
5	Terminologie-Entscheidung zugunsten reiner oBDS-Kodierung bei Episodenart und Modalität	SNOMED-Anschluss und EnLiST-Kompatibilität leiden	ConceptMap-Weg (6.3) statt Ersetzung; SNOMED bleibt am Ziel- und Episoden-Profil
6	Der eingereichte Stand ist gegenüber der kommentierten Fassung fortentwickelt: 1.0.0-ballot enthielt weder den Episodenart-Umbau noch die Trennung von Intention und Kontext	Der Kommentar beschreibt ein Modell, das die Kommentierenden in dieser Form nicht gesehen haben	Im Kommentar ausdrücklich als Fortentwicklung kennzeichnen und die beiden Schritte benennen (2.1); der Leitfaden selbst trägt den beschriebenen Stand
7	EnLiST-Road-Testing bringt Änderungen am Framework	Nachziehen der Extensions und Zählregeln	Als experimentell einbringen (6.6); Versionierung über die Extension-Definition
8	Ergänzungen an Tumorkonferenz sind doch nicht abwärtskompatibel	MTB-Instanzen würden ungültig	Vor Einreichung gegen MTB-Beispielinstanzen validieren (AP 4)
9	Kommentierungsfri st wird verpasst oder der Kommentar wird nicht disponiert; Zieltermin Ende 2027 fällt	Verschiebung um einen vollen Modulzyklus; Leitfaden und Kerndatensatz driften	AP 1 hat Vorrang vor allen anderen Arbeitspaketen; Leitfaden bleibt eigenständig lauffähig, der Rückbau (AP 10) ist bewusst als letzter Schritt geplant

#	Risiko / Entscheidung	Wirkung	Vorschlag
10	Abgrenzung Goal.priority ↔ MII_EX_MTB_Empfehlung_Prioritaet ungeklärt	Doppelte Prioritätsführung	In AP 4 entscheiden; inhaltlich sind es verschiedene Objekte, Doppelung ist vertretbar

Anhang A — Artefaktverzeichnis mit Überleitungsweg

Canonical-Basis des Leitfadens: <https://bih-cei.de/fhir/therapieziele-onkologie>

A.1 Profile

Id	Basis	Weg	Ziel
onko-therapy-goal	Goal	A	neues MII-Profil
onko-behandlungsepisode	EpisodeOfCare	A	neues MII-Profil
onko-care-plan (Empfehlung)	CarePlan	B	mii-pr-onko-tumorkonferenz
onko-care-plan (Behandlung)	CarePlan	D	ISiK → Kernprofile → MII-Ableitung
onko-diagnostic-care-plan (entfallen)	CarePlan	—	im Zuge der Kommentierung gestrichen; Unterscheidung läuft über CarePlan.category
onko-tumorboard-medication-request	MedicationRequest	B	mii-pr-onko-therapieempfehlung-medikation
onko-tumorboard-service-request	ServiceRequest	B	mii-pr-onko-therapieempfehlung-operation
onko-condition (entfallen)	mii-pr-onko-diagnose-primaertumor	C	im Zuge der Kommentierung gestrichen; Referenzen zeigen direkt auf das MII-Profil

A.2 Extensions

Id	Kontext	Weg
onko-therapy-intent	CarePlan, Goal, EpisodeOfCare	A
onko-modalitaet	EpisodeOfCare	A
onko-behandlungskontext	ServiceRequest, Procedure,	A

Id	Kontext	Weg
	MedicationRequest, MedicationAdministration	
onko-careplan-custodian	CarePlan	A (mit B an Tumorkonferenz)
onko-therapy-line- medication-request	EpisodeOfCare	A
enlist-lot	EpisodeOfCare, Procedure	A
enlist-line-segment	EpisodeOfCare, Procedure	A
enlist-countable	EpisodeOfCare	A
enlist-change	MedicationRequest	A (mit B an Therapieempfehlung_Med ikation)

Verwendete HL7-Standard-Extensions ohne Überleitungsbedarf: goal-acceptance, goal-reasonRejected, goal-relationship, workflow-episodeOfCare, request-statusReason.

A.3 Invarianten

Id	Gegenstand	Weg
onko-enlist-1	Designation nur bei Zählstatus counted	A
onko-enlist-2	Notation muss aus Setting, Linie und Modifikation zusammengesetzt sein	A
onko-enlist-3	counted erfordert Designation oder Segment-Marker	A
onko-enlist-4	Designation und Segment- Marker schließen einander aus	A
onko-episode-1	Therapeutische Episodenarten erfordern Diagnosebezug	A
onko-episode-2	EnLiST-Angaben nur bei Episodenart „systemische Therapielinie“	A

Anhang B — Grundlagen

- Implementierungsleitfaden „Therapieziele Onkologie“, de.bih-cei.therapieziele-onkologie 1.0.0-ballot, BIH-CEI
- MII Kerndatensatzmodul Onkologie, de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.onkologie 2027.0.0-ballot.1 (Analysegrundlage) bzw. 2026.0.3 (im Leitfaden gepinnt)
- MII Kerndatensatzmodul Molekulares Tumorboard, de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.mtb 2027.0.0-ballot.1
- ADR-0013 — MII KDS Onkologie als Datenelemente- und Terminologiebasis
- ADR-0015 — Zweischichtiges Zielmodell · ADR-0016 — Generelle Behandlungsepisode · ADR-0017 — Empfehlungs- und Behandlungs-CarePlan
- ADR-0018 — achievementStatus mit Zustandscodes · ADR-0021 — Multimodale Orchestrierung über RequestGroup

- ADR-0023 — target.measure leitlinienversioniert · ADR-0025 — EnLiST-Abbildung
- Saini KS, Koopman M, Martins-Branco D et al. *ESMO adaptation of Lines of Systemic Therapy (EnLiST)*. Annals of Oncology 2026;37(5):608–623. DOI: 10.1016/j.annonc.2026.02.008
- Liefergegenstand LG-01 — Analysebericht „Onkologische Therapieziele“, BIH-CEI